

Fecha Última Actualización: 22-01-2023 7:15:34

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Elizabeth Oriana Abarca San Pedro
Edad : 61a 3m 18d
Dirección : Rupanco 385

Rut : 9.272.027-6
Fecha Nacto: 04/10/1961
Comuna : La Florida

N° Archivo : 2300277
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 3203 0892

N° Epicrisis
338594

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 05/01/2023 01:15

Días Estadía: 17

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 22/01/2023 07:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Elizabeth Abarca San Pedro
Rut: 9.272.027-6
FI HSR: 05/01/2023
FI recu: 05/01/2023
FI UPC : 05/01/2023

Antecedentes

1) Mórbidos:

- HTA
- Hipotiroidismo
- Trastorno depresivo

2) Medicamentos: losartán, levotiroxina, sertralina (se desconoce dosis=

3) Alergias: penicilina

4) Aqx: no reportados

5) Hábitos: se desconoce

Antecedentes descritos, datos rescatados del DAU, paciente ingresa por cuadro que al parecer inicia ayer en la noche caracterizado por cefalea ictal asociado a vómitos explosivos y compromiso de conciencia no bien caracterizado.

Ingresa hipertensa, bradicárdica, GSC de 12 al ingreso según lo descrito, saturando 98% ambiental y HGT normal. Laboratorio de ingreso sólo destaca hipokalemia leve, sin coagulopatía u otra alteración relevante.

Se realiza angioTAC de cerebro, evaluado por neurocirugía con HSA Fisher III obs aneurismática.

Se describe que alrededor de las 00.00-1.00 de hoy 5/01 evoluciona con caída de GSC hasta 8 por lo que se decide intubar para protección de vía aérea (en SU se describe Laringe Cormack III, se intuba al 1er intento con Bougie).

Tac de cerebro de control * aumento de sangrado asociado a vaciado ventricular y leve aumento de tamaño ventricular bilateral. En ese contexto ingresa a pabellón al mediodía de hoy donde se instala DVE sin incidentes, se describe en protocolo salida de LCR hemático a presión.

Se traslada a recuperación en VMI para continuar manejo.

En recuperación se mantiene sedación con fentanyl + propofol en SAS 1 adaptada a VM

Inicia DVA para meta de PAM 65-90

Fecha Epicrisis : 22/01/2023 07:15

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 22-01-2023 7:15:34

Página 2 de 3

Se deja tratamiento ATB con ceftriaxona por antecedente de alergia a penicilina para cobertura de probable neumonía aspirativa, Rx de tórax de control de CVC sin foco neumónico

DVE se deja a 12 cm CAE

Se realiza angiografía cerebral diagnóstica.

Aneurisma de bifurcación de ACM izquierda de 3x2 mm bilobulado. No susceptible de terapia endovascular.

Se traslada a UPC para continuar manejo

Al ingreso

Sedada SAS1

Hemodinamia normotensa, al momento del traslado se suspende noradrenalina por hipertensión

Saturando 98% con FIO2 al 0.3 PEEP 8 VT 400 DP de 12 y compliance de 33

FC de 64 x/

Bien perfundida

Pupilas mióticas simétricas

MP+ bilateral

RR2TSS

ABD BD

Drenaje compresivo a nivel inguinal sin hematoma

Extremidades a derecha en antebrazo zona demarcada por donde habría pasado nora por vía periférica algo indurado

Uñas de manos y pies con esmalte

Diagnosticos de Ingreso :

1.-HSA FISHER III aneurisma de la bifurcación de ACM izquierda

2.-Hidrocefalia-DVE

3.-HTA

4.-Depresión

Durante estancia en UCI se realiza clipaje de aneurisma, procedimiento sin complicaciones aparentes, posteriormente, presenta crisis convulsivas que requiere de manejo con BZD y se carga con LVT; en lo hemodinámico, inicialmente paciente logra metas de PAM de manera espontánea, luego requiere de DVA y, luego de presentar vaso espasmo cerebral, se inicia protocolo con milrinona, mal tolerado, al mismo tiempo, cursó con shock séptico, por lo que requirió de doble apoyo vasopresor, que posterior al manejo ATB, se logra resolver el shock, hasta suspender vasoactivos; desde su ingreso en VM, siempre con buen intercambio gaseoso, sin posibilidad de weaning, inicialmente por compromiso de conciencia, luego por compromiso hemodinámico; sin disfunción renal durante estancia; cursó con varios hits infecciosos, el último, con CAET que reporta K. oxytoca y E. cloacae, por lo que estaba recibiendo manejo con ATB; durante estancia, luego de clipaje, paciente convulsiona, se deja con LVT, sin presentar nuevos episodios, en angio TAS de cerebro de control se percibe vaso espasmo, se inicia protocolo de milrinona, mal tolerado, sin embargo, se resuelve vaso espasmo; el 20.01 se hace obs de oclusión de DVE, es evaluado por neurocx que intenta permeabilizar drenaje y posteriormente la paciente presenta compromiso hemodinámico con hipertensión severa y bradicardia, se realiza TAC de cerebro de control que muestra hematoma de trayecto del DVE con hemoventrículo, se lleva urgente a pabellón donde se drena hematoma, pero paciente, a la evaluación posterior, pierde reflejos de tallo cerebral, se suspende sedación, sin respuesta a estímulos, se conversa situación con familia y se indica LET. Hoy 22.01.23, a las 06:40 horas fallece la paciente

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular hemorrágico (HIC) -

Condición de Egreso Fallecido

fallece

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 22/01/2023 07:15

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 22-01-2023 7:15:34

Página 3 de 3

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

José Alfredo Cadena Oña

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 22/01/2023 07:15

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar